

病患姓名: 陳小明
病歷號: 2025123456
出生年月日: 1990/05/15
性別: 男

主訴:

患者因「反覆腰酸伴隨右側臀部輕微麻木感」就診, 約持續 3 個月, 久坐或搬重物後症狀加劇, 休息後可稍微緩解。

就診時間: 2025-12-20

就診科別: 骨科門診

現病史:

- 約 3 個月前開始出現腰部酸痛, 位置約在下腰(L4-L5 水平)。
- 症狀在長時間坐辦公桌(>2 小時)、搬重物或彎腰時會加重。
- 疼痛有時會放射到右側臀部, 但不會到小腿, 目前無明顯下肢無力。
- 無明顯發燒、體重減輕或夜間劇痛。

過去病史:

- 高血壓: 目前服用降血壓藥, 血壓控制尚可。
- 有過 1 次右手扭傷, 已復原, 無關節炎或自體免疫疾病。

理學檢查(骨科):

- 腰椎前彎測試: 彎腰時右側下腰有輕微壓痛, 左側較不痛。
- 直腿抬高測試: 左右兩側約 80 度均無明顯坐骨神經放射痛。
- 下肢肌力與感覺大致正常, 無明顯神經學缺損。

影像檢查:

- 腰椎 X 光: 整體脊椎排列大致正常, 腰椎前凸略減, L5/S1 椎間盤高度略降低, 符合輕度退化。
- 腰椎 MRI(L3-S1): L5/S1 椎間盤輕度後突, 硬膜囊略受壓, 未明顯壓迫神經根, 無明顯椎管狹窄。

初步診斷:

- 腰椎退化伴隨 L5/S1 椎間盤輕度後突
- 建議: 非手術治療, 包含姿勢調整、核心運動與藥物緩解症狀

醫師建議與生活調整:

1. 避免長時間久坐, 每 30-60 分鐘起身活動 1-2 分鐘。
2. 搬重物時先屈膝下蹲, 避免彎腰直背搬重物。
3. 建議進行溫和的核心訓練(如橋式、輕度平板支撐)與下背伸展運動。
4. 如疼痛較明顯, 可依醫師評估使用非類固醇消炎藥(NSAID), 避免空腹服用。

追蹤安排:

- 1 個月後回診, 評估症狀改善程度與是否需要調整運動計畫。
- 若症狀出現小腿疼痛、無力或大小便控制異常, 需立即回診。

備註:

本診斷為影像與臨床初步評估，需配合實際臨床狀況與醫師判斷，不保證未來病情走向。